



Sortir de l'hôpital — checklist 7 jours

Préparer une sortie d'hospitalisation

Guide offert · édition 2026

Youdom Care — Aide à domicile à Paris & Île-de-France · 01 84 80 72 97 · youdom-care.com

Le retour à domicile après une hospitalisation est une période à haut risque : c'est souvent dans les jours qui suivent la sortie que surviennent complications, réhospitalisations et pertes d'autonomie. Une sortie bien préparée, au contraire, favorise une récupération sereine et sécurisée. Ce guide vous propose un rétroplanning jour par jour, de J-7 à J+7, pour ne rien oublier et coordonner tous les intervenants. Anticiper, c'est éviter le stress et les mauvaises surprises au pire moment.

01 J-7 à J-3 : préparer le retour à domicile

Dès que la date de sortie se précise, prenez contact avec l'équipe soignante et l'assistante sociale de l'hôpital. Demandez une évaluation des besoins à domicile : la personne pourra-t-elle se déplacer, faire sa toilette, se nourrir seule ? Identifiez les aides nécessaires (aide à domicile, infirmier, kinésithérapeute, portage de repas) et anticipez leur mise en place, car les délais de recrutement peuvent être serrés.

Évaluez l'accessibilité du logement : faut-il un lit médicalisé, un fauteuil roulant, un déambulateur, une chaise percée ? Ces dispositifs médicaux, prescrits par le médecin hospitalier, sont livrés par un prestataire et souvent pris en charge par l'Assurance Maladie. Prévoyez leur livraison avant le retour. Vérifiez aussi le chauffage, l'approvisionnement et l'état général du domicile resté vide.

C'est le moment d'informer la famille et d'organiser un roulement de présence pour les premiers jours, période la plus délicate. Renseignez-vous sur le dispositif PRADO (voir plus loin) et sur l'aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) de votre caisse de retraite. Notez tous les rendez-vous de suivi déjà programmés.

À RETENIR

- Contacter l'assistante sociale de l'hôpital dès que la date de sortie est connue.
- Anticiper la mise en place des intervenants : délais de recrutement à prévoir.
- Commander le matériel médical (lit, fauteuil, déambulateur) pour livraison avant le retour.
- Se renseigner sur le PRADO et l'ARDH de la caisse de retraite.

02 J-2 : visite à domicile, courses, organisation

À deux jours de la sortie, effectuez une visite au domicile pour le préparer concrètement. Rangez et sécurisez : dégagez les passages, retirez les tapis glissants, installez des veilleuses, vérifiez l'éclairage. Préparez la chambre où la personne se reposera, à proximité des toilettes si possible, et disposez à portée de main téléphone, lunettes, télécommande et éventuelle téléassistance.

Faites les courses essentielles en tenant compte d'un éventuel régime alimentaire prescrit à l'hôpital : privilégiez des repas faciles à préparer pour les premiers jours, ou activez un service de portage de repas. Vérifiez la présence du nécessaire (produits d'hygiène, linge propre, protections si besoin). Assurez-vous que le réfrigérateur fonctionne et que le logement est chauffé à bonne température.

Confirmez avec chaque intervenant (aide à domicile, infirmier, kiné) l'heure de leur première visite et laissez-leur les coordonnées utiles. Préparez un cahier de liaison où chacun notera ses observations : c'est un outil de coordination précieux entre les professionnels et la famille. Repérez la pharmacie de garde et notez les numéros d'urgence.

À RETENIR

- Sécuriser le domicile : passages dégagés, tapis retirés, veilleuses installées.
- Faire les courses en respectant le régime alimentaire prescrit.
- Confirmer avec chaque intervenant l'heure de sa première visite.
- Mettre en place un cahier de liaison pour coordonner professionnels et famille.

03 J-1 : récupérer ordonnances, kit pharmacie

La veille de la sortie, l'enjeu est le médicament et la continuité des soins. Récupérez auprès de l'équipe hospitalière les ordonnances de sortie : traitements à poursuivre, prescriptions de soins infirmiers, de kinésithérapie, de matériel médical et de transport si nécessaire. Vérifiez que chaque ordonnance est bien datée et signée, et demandez des explications sur tout changement par rapport au traitement habituel.

Passez à la pharmacie avec les ordonnances pour constituer le kit médicaments avant même le retour : cela évite une sortie précipitée en pharmacie le jour J, parfois impossible en soirée ou le week-end. Préparez un pilulier clair pour la semaine et notez les horaires de prise. Signalez au pharmacien tout risque d'interaction ou de doublon avec un traitement en cours.

Constituez une trousse de premiers besoins : thermomètre, tensiomètre si nécessaire, pansements, désinfectant, ordonnance de sortie accessible, compte rendu d'hospitalisation. Rassemblez dans un dossier les documents clés (carte Vitale, mutuelle, coordonnées du médecin traitant et des intervenants). Prévenez le médecin traitant de la sortie et prenez si possible un premier rendez-vous.

À RETENIR

- Récupérer toutes les ordonnances de sortie datées et signées.
- Constituer le kit médicaments en pharmacie dès la veille.
- Préparer un pilulier hebdomadaire clair avec les horaires de prise.
- Prévenir le médecin traitant et fixer un premier rendez-vous de suivi.

04 Jo : la sortie elle-même — coordination

Le jour de la sortie, organisez le transport adapté à l'état de santé : véhicule personnel, VSL ou ambulance sur prescription médicale, prise en charge par l'Assurance Maladie selon les cas. Assurez-vous d'être présent ou qu'un proche accueille la personne à son arrivée : un retour dans un logement vide est source d'angoisse et de risque.

Avant de quitter l'établissement, faites le point avec l'équipe : récupérez le compte rendu d'hospitalisation, la lettre de liaison destinée au médecin traitant, les résultats d'examens et toutes les consignes de surveillance. Posez vos questions sur les signes d'alerte à surveiller, les gestes autorisés ou interdits, la reprise de l'alimentation et de l'activité. Notez ce qui doit être fait dans les 48 heures.

À l'arrivée au domicile, installez confortablement la personne, vérifiez que le matériel médical est en place et fonctionnel, et que les premiers intervenants sont bien programmés. Remplissez la première page du cahier de liaison. Rassurez-vous que le pilulier est prêt et que la première prise de médicament est effectuée à l'heure. Restez présent quelques heures pour sécuriser ce moment charnière.

À RETENIR

- Organiser un transport adapté (VSL, ambulance) sur prescription si besoin.
- Ne jamais laisser la personne rentrer dans un logement vide.
- Récupérer compte rendu, lettre de liaison et consignes de surveillance.
- Vérifier matériel, pilulier et présence des premiers intervenants à l'arrivée.

05 J+1 à J+3 : surveillance, alertes, suivi

Les 72 premières heures sont les plus critiques. Surveillez attentivement l'état général : température (fièvre), douleur, état de la cicatrice ou du site opératoire (rougeur, écoulement, chaleur), respiration, hydratation, alimentation et transit. Notez tout dans le cahier de liaison pour un suivi objectif. Une reprise trop rapide d'activité ou au contraire un alitement prolongé peuvent nuire : suivez les consignes médicales.

Assurez-vous que chaque intervenant passe comme prévu et que les soins (pansements, injections, rééducation) sont réalisés. Vérifiez la bonne prise des médicaments à l'aide du pilulier. Encouragez la mobilisation douce et l'hydratation, surveillez le risque de chute encore accru par la fatigue et l'éventuelle désorientation post-hospitalisation.

Connaissez les signes qui imposent d'appeler : fièvre élevée, douleur intense ou inhabituelle, essoufflement, saignement, confusion soudaine, absence d'urines, cicatrice qui s'infecte. En cas de doute, contactez le médecin traitant, la ligne de l'établissement ou le 15. Mieux vaut une alerte injustifiée qu'une complication tardive. Confirmez les rendez-vous de suivi à venir.

À RETENIR

- Surveiller température, douleur, cicatrice, hydratation et transit sur 72 h.
- Vérifier le passage des intervenants et la bonne prise des médicaments.
- Connaître les signes d'alerte imposant d'appeler le médecin ou le 15.
- Prévenir les chutes, favorisées par la fatigue et la désorientation.

06 J+7 : bilan, ajustements

Une semaine après le retour, faites un bilan complet de la situation. La récupération suit-elle le cours attendu ? Les intervenants sont-ils suffisants, ou faut-il augmenter le nombre d'heures d'aide à domicile ? Certains besoins non anticipés apparaissent souvent après quelques jours : aide à la toilette plus poussée, préparation des repas, accompagnement psychologique face à la fatigue ou au moral en berne.

Vérifiez le rendez-vous de suivi avec le médecin traitant et l'avancée des soins prescrits. Ajustez le plan d'aide si nécessaire : le retour à domicile est une phase évolutive, pas un état figé. Si la perte d'autonomie semble durable, c'est le moment d'engager une demande d'APA ou de faire réévaluer un plan d'aide existant.

Faites le point avec la famille et les intervenants à partir du cahier de liaison : ce qui fonctionne, ce qui manque, ce qui inquiète. Célébrez aussi les progrès, importants pour le moral. Un accompagnement professionnel coordonné, comme celui de Youdom Care, permet d'adapter en continu l'aide au rythme réel de la convalescence.

À RETENIR

- Évaluer si le nombre d'heures d'aide est suffisant et ajuster le plan.
- Confirmer le suivi médical et l'avancée des soins prescrits.
- Engager une demande d'APA si la perte d'autonomie s'annonce durable.
- Faire le point avec famille et intervenants via le cahier de liaison.

07 Le PRADO de l'Assurance Maladie

Le PRADO (Programme d'Accompagnement du Retour À Domicile) est un service gratuit de l'Assurance Maladie destiné à fluidifier la sortie d'hospitalisation. Un conseiller de l'Assurance Maladie rencontre le patient à l'hôpital, avant la sortie, pour organiser le retour : prise de rendez-vous avec les professionnels de santé de ville (infirmier, kinésithérapeute, sage-femme selon les cas), coordination des soins et information sur les droits.

Le PRADO couvre plusieurs situations : maternité, chirurgie, pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, BPCO) et, de plus en plus, les personnes âgées. L'objectif est d'éviter les ruptures de prise en charge et de réduire les réhospitalisations. Le service est proposé par l'équipe hospitalière ; il suffit d'accepter l'accompagnement lorsqu'il est offert.

N'hésitez pas à demander vous-même si un accompagnement PRADO est possible, notamment pour une personne âgée fragile. Le conseiller peut également orienter vers les aides sociales et les dispositifs complémentaires. C'est un relais précieux, gratuit, qui décharge la famille d'une partie de l'organisation logistique des soins.

À RETENIR

- Service gratuit de l'Assurance Maladie pour organiser le retour à domicile.
- Un conseiller rencontre le patient à l'hôpital et coordonne les soins de ville.
- Couvre maternité, chirurgie, pathologies chroniques et personnes âgées.
- Demander à en bénéficier si l'accompagnement n'est pas spontanément proposé.

08 Les aides mutuelle souvent ignorées

Comme évoqué pour les seniors en général, de nombreuses complémentaires santé prévoient des garanties d'assistance spécifiquement activables après une hospitalisation : heures d'aide-ménagère, portage de repas, garde d'enfants, aide à la personne pendant la convalescence, voire transport ou soutien psychologique. Ces prestations sont incluses dans le contrat, sans frais supplémentaires, mais rarement utilisées faute d'information.

Le déclenchement est simple : appelez la plateforme d'assistance de votre mutuelle (numéro au dos de la carte de tiers payant) dès que la sortie est programmée, ou même avant. Décrivez la situation ; un conseiller précisera les services mobilisables et les mettra en place, souvent en 24 à 48 heures et sans avance de frais. Certaines garanties nécessitent un nombre de jours d'hospitalisation minimum : vérifiez les conditions.

Ne négligez pas non plus les garanties de votre contrat de prévoyance ou d'assurance emprunteur, qui peuvent inclure des services d'assistance. Un simple appel peut vous faire gagner des heures d'aide précieuses dans la période sensible du retour. Le réflexe « mutuelle » doit devenir automatique à chaque hospitalisation.

À RETENIR

- De nombreuses mutuelles offrent une aide à domicile après hospitalisation, sans surcoût.
- Appeler la plateforme d'assistance dès que la sortie est programmée.
- Prestations mises en place en 24-48 h, sans avance de frais.
- Vérifier aussi les garanties de prévoyance et d'assurance emprunteur.

✓ Votre checklist récapitulative

- ☐ Contacter l'assistante sociale et anticiper les intervenants dès J-7.
- ☐ Commander le matériel médical pour livraison avant le retour.
- ☐ Sécuriser le domicile et faire les courses adaptées au régime prescrit.
- ☐ Récupérer toutes les ordonnances et constituer le kit médicaments à J-1.
- ☐ Organiser un transport adapté et un accueil à domicile pour J0.
- ☐ Surveiller étroitement l'état de santé et les signes d'alerte de J+1 à J+3.
- ☐ Faire un bilan à J+7 et ajuster le plan d'aide si besoin.
- ☐ Accepter l'accompagnement PRADO et activer les garanties de la mutuelle.

Une sortie d'hôpital à préparer ? Youdom Care coordonne le retour à domicile et met en place l'aide dès le premier jour. Contactez-nous au 01 84 80 72 97 ou sur youdom-care.com.

Nos coordinatrices vérifient gratuitement vos droits et montent les dossiers à votre place.

Réponse en moins de 2 h ouvrées · Visite à domicile gratuite · Sans engagement.

 **01 84 80 72 97**

Ce guide est fourni à titre informatif et ne se substitue pas à un conseil personnalisé. Informations à jour en 2026, susceptibles d'évoluer. © Youdom Care.